

사 업 명						
(21) 국립심뇌혈관센터 설립 (6631-309)						

1. 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	질병관리청	국립보건연구원	0	090	091
명칭					보건	보건의료

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	6600	6631	309
명칭	보건의료연구관리	질병연구기획관리	국립심뇌혈관센터 설립

2. 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○						

3. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2022년 결산	2023년 예산 본예산(A)	2024년		증감 (B-A)	(B-A)/A
			정부안	확정(B)		
국립심뇌혈관센터 설립	-	2,500	-	330	△2,170	△86.8

4. 사업목적·내용

- (국립심뇌혈관센터 설립) 심뇌혈관질환의 국가차원의 통합적이며 체계적인 연구 관리와 국가심뇌혈관질환 정책-연구-진료현장 간 분절된 지식의 통합·조정을 위해 국가심뇌혈관질환 센터 설립

5. 사업근거 및 추진경위

- ① 법령상 근거 조항 적시 : 해당 없음
- ② 추진경위
 - 文정부 지역공약 - (광주·전남 상생)전남 장성, 광주 북구를 포함한 광주연구개발

특구 내 국립심혈관센터 건립

- (2019) 심뇌혈관질환 관리 중앙기구 마련은 지속적으로 요구, 지역공약 이행을 계기로 설립 논의 본격화(보건복지부 질병정책과 주관)
- (2019.03) 복지부 1차 연구용역 완료(국립심혈관센터 및 심장수술센터 구축방안 연구, 보건산업진흥원)
 - * 연구개발, 정책지원 및 진료(500병상)를 포함한 모형 제시(건립비 3,000억, 운영비 약 1,400억)
- (2019.05) 관련 학회, 권역심뇌센터, 환자단체 등 공청회 및 전문가 토론회 개최
 - * 과도한 재정소요, 기 구축 권역센터와의 기능 중복 등으로 부속병원 불필요 또는 최소화 의견 제시
- (2019.07~08) 유관기관 및 전문가 등의 검토의견을 반영한 설립 추진 방안 마련
 - * 정책기능 배제, 순수 연구기관으로서의 설립 필요성 및 국가 조직화 등
- (2020.04) 설립지역 검토, 세부 운영모델 마련 등을 위한 복지부 2차 연구용역 진행 (국립심뇌혈관질환연구소 설립 타당성 및 기본계획 수립, 보건산업진흥원)
- (2020.11) 질병관리청 승격 후 설립 관련 업무의 질병관리청 이관
- (2021.04~10) 구체적 설립계획 수립을 위한 질병청 주관의 ‘국립심혈관연구소 세부 운영 및 건립기본계획 수립’ 연구용역(2과제) 진행
- (2022.01~04) 필요 예산 증가에 따른 총사업비 증액 조정 요구 (475→1,094억)
- (2022.05) 총사업비 관리지침에 따른 타당성 재조사 진행
- (2023.07) AHP평가를 위한 분과위원회 개최, 제3차 재정사업평가위원회에서 타당성 재조사 최종 통과 의결 (설립비용 1,001억, 면적 19,798㎡)
- (2023.07~10) 타당성 재조사 결과 기반 기재부(총사업비관리과) 총사업비 조정 협의 진행 및 보류 결정
 - * 보류사유: 국립보건연구원 소속 국가연구소 설립에 대한 행안부 협의 필요
- (2023.12) 유사 국가 연구기관 설립 사례 등 총사업비 조정에 필요한 자료 기재부 제출

6. 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : (당초) 475억원 → (요구) 1,001억 (총사업비 조정 협의중)
- 사업기간 : (당초) 2021 ~ 2024 → (요구) 2021 ~ 2029
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추정편성한 연도에는 추정포함)

연도	2020	2021	2022	2023	2024
사업비	-	-	-	-	330

- 사업규모 : 연구소 1개소, 총 연면적 19,798m² (부지 24,255m²)

* 총사업비 조정 결과에 따라 사업 규모 조정

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행
- 사업시행주체 : 질병관리청
- 사업 수혜자 : 심뇌혈관질환연구 관련 보건의료 산·학·연·병
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

7. 사업 집행절차

